KDA 경기도치과의사회 GYEONGGI DENTAL ASSOCIATION
GAMEX 2026

약물 관련 치과치료 가이드라인과 응급 및 긴급상황 대처법

어떤 약을 처방해야 할까요?

01 위장장애가 있어요(속이 쓰려요)



- NSAID 보다는 AAP(아세트아미노펜, 타이레놀)를 처방
- 제산제(알마겔 등)를 처방해도 속이 쓰리다고 하면,
 위산분비억제제(PPI, P-CAB)를 같이 처방
 P-CAB의 경우 식전 식후 복용 영향 없어 최근 추천
- 경구 스테로이드(소론도)도 NSIAD와 병용시
 위염, 위궤양, 위장관 출혈 등의 위험 높아요.
 — 장기간 사용이 필요하거나 NSAID 병용 시 PPI 투여
- 처방 항생제로 설사 등 흔한 부작용 발생 시 다른 항생제로 교체
 — 반복되면 유산균·지사제·진경제 단기 처방 고려

02 간이 안 좋아요.



- 일반적 치과 처방약은 대부분 괜찮음
- 진통제 선택시 AAP(간대사 약물이지만)를 4g/day이하
 (간경화 등 간 질환자 2g/day 이하) 로 처방
- NSAID는 출혈 유발 위험 및 신기능·복수 악화 위험으로,
 진행된 간경변에서는 피할 것
- 조절 되지 않는 황달·복수·간성뇌증 등 비대상성 간경변증이 있으면
 소화기내과와 상의 후 약물 조절

03 신장이 안 좋아요, 또는 신장 투석중이에요.



■ 항생제
-만성 신장병 환자는 신기능(사구체여과율)에 맞는 항생제의 용량조절이 필요
— 일반적 치과진료시 항생제가 필요한 경우 사구체여과율(eGFR) 10ml/min이상이라면
오구멘틴(amoxicillin/clavulanate) 375mg 1T BID로 처방 가능
(단, 10 이하인 경우 375mg 1T QD, 30 이상인 경우 625mg 1T BID)
-투석중이라면
— 항생제는 오구멘틴(amoxicillin/clavulanate) 375mg 1T BID
or 625mg 1T QD + 혈액투석 후 1T 추가

■ 진통제
-NSAID의 처방은 최대한 피하는 것이 필요, 잔여 신기능 보호 위해 AAP를 가장 추천
그리고 통증 조절을 위해 트라마돌(트리돌) or AAP+트라마돌(울트라셋)도 가능

04 페니실린에 알러지가 있는거 같아요.



- 퀴놀론계(레보플록사신, 목시플록사신 등)로 처방
 — 아나필락시스 발생 가능성 낮고 구강내 세균(Gram(+)등) 커버 가능
 소아, 청소년은 금기!!!! 시프로플록사신 은 항균 범위로 인해 비추천
- 마크로라이드계(아지스로마이신, 클래리스로마이신),
 클린다마이신(홀그램 등, 장기간 복용은 피함) 가능
- 로도질(메트로니다졸+스피로라이드) 가능

05 NSAIDs(이부프로펜, 디클로페낙, 아세클로페낙등)에 알러지가 있는거 같아요

- AAP 가장 추천
- 트라마돌 or AAP+트라마돌로 처방 가능

06 치과 처방약에 알러지가 있는거 같은데 무엇인지 모르겠어요.

- 퀴놀론 항생제와 AAP 해열진통제로 처방
- 알러지가 심하지 않는 경우 항생제 · NSAID 중
 선택 처방하여 원인 약물을 먼저 파악

07 상악동염이 왔어요.



- 항생제는 가장 먼저 오구멘틴(amoxicillin/clavulanate)을
 선택하는 것이 좋음
 (단, 시간이 경과 후 pus D/C 될 경우에는 메트로니다졸까지 함께 처방을 고려)
- 페니실린 알러지가 있을 때는 그람 양성균 항균력이 강화된
 퀴놀론(레보플록사신, 목시플록 사신) 사용 고려
- NSAID와 슈도에페드린(슈다페드, 혈관수축작용), 스테로이드(소론도)는
 일주일 이내로 사용, 이후에도 증상 호전이 없으면 환기 등의 수술적 접근이 필요

08 신경손상이 왔어요.



- 위장 장애에 주의하며 손상 즉시 스테로이드(소론도 5mg)를
 오른쪽 표와 같이 처방하고 원인 제거
 (부신억제 예방을 위해 오전 한번에 복용도 고려할 수 있음)
- 가바펜틴(뉴론틴), 비타민 B12(코발라민)도 처방 가능
 치료기간 지체 시 법적 문제 등을 위해 상급병원 의뢰 필수

Solondo
– 지각이상 전후 예방적 약 12일간 42T 복용법

	1-2일	3-4일	5-6일	7-8일	9-10일	11-12일
아침	2T	2T	2T	1T	1T	1T
점심	2T	1T	1T	1T	X	X
저녁	2T	2T	1T	1T	1T	X

정해진 용법 · 용량과 복용 기간을 지켜 복용하세요.
부신억제 예방을 위해 오전에 한번에 복용도 가능합니다.

응급 및 긴급상황 대처법

알러지/과민반응(아나필락시스)



· 항생제, 백신, NSAIDS, 라텍스, 마취제에 의해 발생 가능
· 응급상황(아나필락시스) 대비 1:1000 0.3~0.5ml 근육주사 준비(에피펜)
· 항히스타민 ,스테로이드 투약 고려
호흡·맥박 소실 시 즉시 흉부압박, 기도확보, 119

간질



· 전조증상 있다면 알리도록 미리 지시
· 간질 발작 시 즉시 모든 기구를 입안에서 제거, 옆으로 뉘이고 기도 내 이물질 Suction
5분 이상 지속 시 119

저혈압성 실신, 기립성 실신



· 어지러움을 호소 시 누운 자세 유지, 혈압 측정
· 천천히 움직이도록 지시, 가능하면 수액 로딩과 산소 투여

미주신경 반응/혈관미주신경성 실신



· 긴장한 젊은 여성이 많으나 남성이나 고령에서도 발생 가능
· 저혈압과 서맥을 동반한 짧은 의식소실 혹은 발작 발생 가능
· 발생이 의심되면 수액 정주 및 맥박이 40회 미만이면 아트로핀 0.5 or 1mg 정주
· 대부분 안정자세 + 수액 로딩으로 회복
만약 의식이 돌아오지 않는다면 즉시 흉부 압박, 기도 확보 및 119

과환기(과호흡증후군)



· 긴장이 과도한 경우 호흡곤란으로부터 빠른 과호흡 상태가 진행, 경직 발생 가능
· 체내 이산화탄소 분압이 저하되므로, 안정을 유도하면서 천천히 호흡하도록 유도
· 종이봉투를 이용한 재호흡법은 저산소·심근허혈 환자에 위험할 수 있어 최근 비권장
증상이 지속되거나 흉통, 의식저하가 동반되면
심질환·저산소증 등을 의심하고 119연락 응급 후송

본 가이드라인은 임상적 참고를 위한 것으로, 개별 환자에 대한 확정적인 치료 지침은 아니오니,
실제 처방 시 반드시 환자의 상태를 면밀히 평가한 후 진행하시기 바랍니다.

presented by 유재식 제이탑치과의원 JTOP DENTAL CLINIC (전) 조선대학교 치과대학 구강악안면외과 교수